



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
(NICU)
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 826.15/I-PDM/NICU/IX/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT* (NICU)
~~DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA~~

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan dan efisien bagi pasien *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di rumah sakit
- b. Bahwa dengan di tetapkannya pedoman pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di rumah sakit dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di rumah sakit
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan (masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 17/2023). Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan kelas D
8. Pedoman Uraian Tugas Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2023
9. Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
10. Standar Peralatan Keperawatan Dan Kebidanan Di Sarana Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
11. Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
12. Pedoman Perancangan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
13. Pedoman Pelayanan Rawat Gabung di RS, Departemen Kesehatan 2022.
14. Pedoman Pelayanan Perinatal Pada Rumah Sakit Umum kelas C

-
- Dan D Departemen Kesehatan 2022.
15. Panduan Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir Untuk Dokter, Bidan Dan Perawat Di RS, Departemen Kesehatan – IDAI 2022.
 16. Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B (non pendidikan), C dan D, Departemen Kesehatan 2022.
 17. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
 18. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN *Neonatal Intensive Care Unit*
(NICU)

Pasal 1

- (1) Pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah unit perawatan intensif di rumah sakit yang dikhususkan untuk bayi baru lahir (neonatus) yang membutuhkan pemantauan medis ketat dan bantuan teknologi tingkat tinggi.
- (2) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan NICU
- (3) NICU adalah ruangan intensive penerima rujukan pasien dari rumah sakit lain sesuai standart dan fasilitas yang dimiliki dan bila pasien memerlukan perawatan intensive yang lebih tinggi tingkatannya dapat di rujuk ke rumah sakit lain sesuai dengan kondisi pasien

Pasal 2

- (1) Kriteria dokter *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah telah mengikuti Pendidikan / Pelatihan dan telah mendapat sertifikat melalui program pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh perhimpunan profesi yang terkait
- (2) Staf yang ada di Pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah staf yang berkompeten dan terlatih serta memiliki sertifikat NICU.

Pasal 3

- (1) Indikasi pemeriksaan laboratorium dan radiologi berdasarkan permintaan dari DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) atau dokter konsulen lain berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien
- (2) Setiap permintaan laboratorium dan radiologi di input oleh staf untuk selanjutnya di informasikan pada bagian terkait.

Pasal 4

- (1) Ada pembayaran *Done Payment* (DP) kepada pasien umum selama perawatan dan menggunakan alat bantu.

BAB II

KRITERIA KELUAR MASUK NICU

Pasal 5

- (1) Ada kriteria masuk dan keluar NICU, tingkat pelayanan neonatus, diagnostik, serta kriteria berbasis fisiologi dan kualitas hidup (*quality of life*).
- (2) Staf yang kompeten dan berwenang dari NICU terlibat dalam menentukan kriteria
- (3) Staf terlatih untuk melaksanakan kriteria
- (4) Pasien yang membutuhkan perawatan di *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan serta memberikan persetujuan untuk di rawat di NICU.
- (5) Catatan medis pasien yang diterima masuk di atau keluar dari unit intensive atau unit spesialisasi memuat bukti bahwa pasien memenuhi kriteria masuk atau keluar.

Pasal 6

- (1) Ada peraturan tentang kriteria masuk dan keluar NICU yang dimaksud, meliputi :
 - a. Kriteria masuk NICU : *Syndrome Gawat Nafas/ Respiratory Distress Syndrome, Retinopathy of Prematurity (ROF), Transient Tachycardia of Newborn (TTN), Hyaline Membrane Disease (HMD)*, pneumonia neonatal, asfiksia, aspirasi meconium, ancaman gagal nafas dan gagal nafas, *Bronchopulmonary dysplasia (BPD)*, memerlukan oksigenasi intensif dan agresif, anemia, apnea, Perdarahan Saluran Cerna atas dan bawah yang masif, *Necrotizing Enterocolitis Necrotion (NEC)*, Syok Hipovolemik, Post Resusitasi, Kejang, Kern ikterik/ ensefalopati hiperbilirubinemia, *Hemorrhagic Disease of newborn (HDN)*, Bayi berat badan lahir amat/ sangat rendah (< 16 mg/dl, Neonatus yang memerlukan nutrisi parenteral total atau parsial
 - b. Kriteria keluar NICU : Bayi telah menunjukkan tanda vital stabil di boks terbuka selama 24-48 jam. Normalnya, suhu tubuh bayi 36,50 C-37,50 C, frekuensi pernapasan 30-40 x/mnt, nadi 120-160 x/mnt, keberhasilan menyusui sudah mulai tercapai, penambahan berat badan dengan pemberian asupan per oral telah terlihat, semua obat yang diperlukan dapat diberikan per oral, nilai laboratorium telah normal, ibu dan ayah memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh neonatus, pasien meninggal, rujuk, dan pulang Paksa (APS)
 - c. Yang menentukan pasien bisa masuk NICU adalah dokter kepala NICU.

BAB III

KETENTUAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Pasal 7

- (1) Setiap penggunaan peralatan medis di ruang NICU di informasikan kepada penanggung jawab pasien (orangtua)
- (2) Setiap pemasangan atau tindakan medis di ruang NICU di informasikan kepada penanggung jawab pasien (orangtua)

Pasal 8

- (1) Pasien yang dirawat di NICU tidak diperbolehkan untuk di dampingi maupun di kunjungi selama di rawat di ruangan, apabila terjadi perubahan kondisi pasien staff wajib memberikan informasi kepada keluarga.

Pasal 9

- (1) Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis tetapi dengan pertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan-tindakan tertentu dapat di delegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih.
- (2) Pada keadaan darurat, untuk kepentingan terbaik pasien, dokter jaga NICU atau dokter spesialis anestesi dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan dan informasi dapat diberikan pada kesempatan pertama.
- (3) Pada pasien yang berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasi diketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien, dokter dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi.
- (4) Pencatatan nilai – nilai pengukuran tanda vital secara berkala dilakukan perawat NICU 1 jam sekali dengan interval disesuaikan dengan kondisi pasien pada lembar kardek NICU
- (5) Pemantauan secara umum dan khusus. Setiap pagi hari oleh dokter jaga dan perawat NICU dan dikoordinasikan dengan dokter DPJP

Pasal 10

- 1) Penundaan dan keterlambatan pelayanan di rawat inap harus disampaikan kepada pasien.
- 2) Semua pasien diberitahu alasan penundaan dan keterlambatan pelayanan dan diberi informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinik pasien dan dicatat di Rekam Medis.

Pasal 11

- 1) Dilakukan rencana pemulangan pasien (*Discharge Planning*) bagi pasien yang rencana pemulangannya kompleks dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP, untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pelayanan pasien.
- 2) Discharge Planning dilakukan secara terintegrasi antar PPA terkait dan difasilitasi manager pelayanan pasien (MPP).

Pasal 12

- 1) Semua pasien rawat inap ditentukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang bertanggung jawab mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinisnya serta melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.
 - a. DPJP yang ditunjuk harus tercatat namanya di rekam medis
 - b. DPJP memberikan keseluruhan asuhan selama pasien di Rumah Sakit dan berkolaborasi serta komunikasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya.

BAB IV

RUJUKAN KELUAR

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit memiliki staf terlatih yang mengelola rujukan
- (2) Rumah Sakit bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan
- (3) Rumah Sakit melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah sakit Rujukan

BAB V

PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 08 September 2025

PLT DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Tahun 2025

Disusun oleh:

Kepala Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)



(dr. Dicky Faturrachman , Sp.A, M. Biomed)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) ini yang mulai dipergunakan pada Tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah Pedoman Pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 08 September 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Ruang Lingkup Pelayanan	5
1.3 Batasan Operasional	5
BAB II STANDART KETENAGAAN	
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia	7
2.2 Distribusi Ketenagaan	7
2.3 Pengaturan Jaga	8
BAB III STANDART FASILITAS	
3.1 Denah Ruangan	9
3.2 Standart Fasilitas	9
3.3 Persyaratan Khusus	9
BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN	
4.1 Pelayanan yang dapat dilakukan di ruang NICU	11
4.2 Pelayanan yang tidak dapat dilakukan di ruang NICU	11
BAB V KEMAMPUAN PELAYANAN	
5.1 Kriteria Pasien Masuk NICU	13
5.2 Kriteria Pasien Keluar NICU	13
5.3 Monitoring dan Evaluasi Pasien	14
5.4 Jenis Pelayanan di ruang NICU	14
5.5 Penggunaan Alat Medik	14
5.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan	14
5.7 Pasien Pulang	15
5.8 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan	15
BAB VI LOGISTIK	
BAB VII KESELAMATAN PASIEN	
7.1 Pengertian	21
7.2 Tujuan	21

7.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien	21
BAB VIII KESELAMATAN KERJA	
8.1 Pengertian	23
8.2 Prinsip Dasar Usaha Keselamatan Kerja	23
8.3 Tujuan Keselamatan Kerja	24
8.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja	24
8.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkannya	25
8.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja	26
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	
9.1 Upaya Peningkatan Mutu	28
9.2 Definisi Indikator	28
9.3 Kriteria	29
9.4 Standart	31
BAB X PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan neonatus (bayi baru lahir usia 0-28 hari) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan nasional. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih menjadi tantangan besar, di mana sebagian besar kematian terjadi pada masa neonatal akibat komplikasi kelahiran prematur, asfiksia neonatorum, infeksi (sepsis), dan kelainan kongenital.

Seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, bayi prematur dengan berat lahir rendah yang dahulu memiliki harapan hidup kecil, kini memiliki peluang hidup yang lebih besar jika mendapatkan perawatan intensif yang tepat. *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) hadir sebagai unit pelayanan khusus yang menyediakan pemantauan berkelanjutan, bantuan teknologi bantuan hidup (seperti ventilator dan CPAP), serta intervensi medis khusus oleh tenaga profesional yang kompeten.

Penyusunan Pedoman Pelayanan NICU di Rumah Sakit Prima Husada Malang didasarkan pada kebutuhan untuk menstandarisasi prosedur klinis, penggunaan alat kesehatan, dan koordinasi antar staf demi meminimalkan risiko medis. Selain itu, pedoman ini disusun untuk memenuhi amanat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, khususnya pada kelompok Program Nasional dalam upaya penurunan angka kematian bayi melalui pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 jam.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh staf medis di unit NICU memiliki acuan yang jelas dalam memberikan asuhan keperawatan dan medis yang berkualitas, aman, dan berfokus pada pasien (*Patient Centered Care*), serta melibatkan keluarga dalam proses perawatan bayi (*Family Centered Care*).

1.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan yang diberikan di NICU adalah sebagai berikut :

1. Lingkup Tindakan Medis dan Keperawatan
 - a. Resusitasi Neonatus: Penanganan gawat darurat di ruang bersalin atau OK.
 - b. Manajemen Termoregulasi: Perawatan dalam inkubator atau infant warmer.
 - c. Manajemen Nutrisi: Pemasangan OGT/NGT, pemberian ASI eksklusif, dan nutrisi parenteral.
 - d. Terapi Cairan: Pemasangan jalur intravena perifer maupun umbilikal (UVC/UAC).
 - e. Skrining Neonatus: Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan Skrining Penyakit Jantung Bawaan
2. Lingkup Dukungan Keluarga (*Family Centered Care*)
 - a. Edukasi dan Konseling Menyusui: Dukungan pemberian ASI perah di area intensif.
 - b. Perawatan Metode Kanguru (PMK): Fasilitasi kontak kulit ke kulit antara orang tua dan bayi prematur.
 - c. Dukungan Psikososial: Pendampingan bagi orang tua selama bayi dirawat kritis.

1.3 Batasan Operasional

- a. Gangguan respirasi
- b. Gangguan kardiovaskuler
- c. Skor APGAR kurang dari 4
- d. Berat lahir sangat rendah (>1500 gram)

-
- e. Kurang bulan dengan umur kehamilan > 32 minggu
 - f. Neonatus dengan gangguan susunan saraf pusat seperti kejang dan ensefalopati hipoksik iskemik
 - g. Gangguan saluran cerna berat, seperti NEC dan perdarahan saluran cerna
 - h. Bayi dari ibu Diabetes
 - i. Bayi yang lahir dari kehamilan berisiko tinggi atau persalinan dengan komplikasi
 - j. Gawat nafas yang tidak memerlukan ventilasi bantuan
 - k. Hiperbilirubinemia yang perlu terapi sinar
 - l. Sepsis neonatorum
 - m. Hipotermi

BAB II

STANDART KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi sumber daya manusia di Instalasi NICU adalah :

1. Tenaga Medis

- a. Terdidik dan bersertifikasi sebagai seorang spesialis anak melalui program pelatihan dan pendidikan yang diakui oleh perhimpunan profesi yang terkait
- b. Menunjang kualitas pelayanan NICU dan menggunakan sumber daya secara efisien
- c. Mendarmabaktikan lebih dari 50% waktu profesinya dalam pelayanan NICU
- d. Bersedia berpartisipasi dalam suatu unit yang memberikan pelayanan 24jam/ hari, 7 hari/ minggu
- e. Mampu melakukan prosedur critical care, antara lain:
 - 1) Memasang dan mempertahankan jalan napas termasuk intubasi dan ventilasi mekanis
 - 2) Mengambil kateter intravaskuler untuk monitoring invasive maupun terapi invasive Resusitasi jantung paru
- f. Selalu mengikuti perkembangan mutakhir dengan membaca literature kedokteran
- g. Berpartisipasi dalam program-program pendidikan dokter berkelanjutan

2. Tenaga Keperawatan

Perawat yang bertugas di Neonatus Intensive Care Unit Rumah Sakit Prima Husada harus terlatih serta jumlahnya sesuai dengan ketersediaan inkubator, cuve, CPAP, Ventilator, maupun box yang terpakai. Kemampuan setara dengan tingkat pelayanan kesehatan neonatus

2.2 Distribusi Ketenagaan

Standar pelayanan intensive care unit pada rumah sakit tipe C terdiri dari :

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi NICU	1 shift	1 orang
Kepala ruang NICU	1 shift	1 orang
Penanggung Jawab shift	3 shift	3 orang

Perawat Pelaksana	3 shift	4 orang
-------------------	---------	---------

2.3 Pengaturan Jaga

Pengaturan Jaga di Ruang NICU adalah sebagai berikut :

1. Tenaga medis :
 - a. Dokter Spesialis Anak berjaga secara on call
 - b. Dokter Umum berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam. Dokter Umum merangkap sebagai dokter IGD dan dokter jaga ruangan.
2. Tenaga Perawat/Bidan
 - a) Terdiri dari Bidan dan Perawat di ruangan yang berjaga secara on site, dalam 24 jam terbagi menjadi 3 waktu dinas, yaitu Dinas Pagi, Sore dan Malam.
 - b) Pembagian waktu jam dinas yaitu
 - 1) Dinas Pagi dari jam 06.30 - 14.00
 - 2) Dinas Sore dari jam 14.00 – 21.00
 - 3) Dinas Malam dari jam 21.00 - 07.00
 - c) Pengaturan jadwal dinas Perawat di ruangan dilakukan oleh Kepala Ruangan
 - d) Apabila ada pegawai yang mengalami sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal, serta musibah maka penjadwalan dinas diatur kembali oleh Kepala ruangan, dan tidak ada penggantian dinas.

BAB III STANDART FASILITAS

3.1 DENAH RUANGAN

Terlampir

3.2 STANDART FASILITAS

NO	NAMA RUANGAN	FUNGSI	BESAR RUANG/LUAS	KEBUTUHAN FASILITAS
1	Ruang Perawatan NICU	Ruangan untuk pasien yang memerlukan asuhan dan pelayanan keperawatan dan pengobatan secara berkesinambungan lebih dari 24 jam	Ukuran ruangan minimal 6m x 8m	Inkubator, Cuve, Infant radiant warmer, Fototerapi, CPAP, Suction, Resusitasi kit, Monitor
2	Ruang Stasi Perawat (Nurse Station)	Ruang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian asuhan dan pelayanan keperawatan (pre dan post conference, pengatur jadwal), dokumentasi sampai dengan evaluasi pasien	3 - 4 m ² /perawat (Ket: perhitungan 1 stase perawat untuk melayani maksimum 4 tempat tidur)	Meja, Kursi, lemari arsip, lemari obat, telepon/intercom alat monitoring untuk pemantauan terus menerus fungsi-fungsi vital pasien
3	Ruang Linen Bersih	Tempat penyimpanan bahan-bahan linen steril/bersih	Min. 4 m ²	Lemari
4	KM/WC (petugas)	KM/WC	KM/WC Pria/wanita luas 2 m ² - 3 m ²	Kloset, wastafel, bak air

3.3 PERSYARATAN KHUSUS

Perletakan ruangnya secara keseluruhan perlu adanya hubungan antar ruang dengan skala prioritas yang diharuskan dekat dan sangat berhubungan /membutuhkan.

1. Aksesibilitas : Lokasi NICU harus berdekatan (satu lantai atau akses *lift* khusus) dengan Kamar Bersih (VK) dan Kamar Operasi (OK) untuk mempercepat pemindahan bayi baru lahir yang kritis (PONEK).
2. Area Tertutup : Harus merupakan area terbatas (*restricted area*) dengan pintu masuk ganda (antar-ruang) untuk menjaga kestabilan suhu dan kebersihan udara.

-
3. Zonasi Internal : Harus memiliki pembagian area yang jelas:
 - a) Area perawatan (Intensif, Intermediate, Isolasi).
 - b) Area laktasi (ruang menyusui/memerah ASI).
 - c) Area penyimpanan alat bersih.
 - d) Area kotor (*dirty utility*) untuk pembuangan limbah
 4. Jarak Antar Tempat Tidur : Minimal 1,5 - 2 meter untuk mencegah infeksi silang dan memberikan privasi saat orang tua melakukan metode kanguru.
 5. Pencahayaan :
 - a) Harus menggunakan sistem dimmer (bisa diredupkan). Bayi prematur sangat sensitif terhadap cahaya terang, cahaya yang terlalu kuat dapat mengganggu perkembangan retina dan otak.
 - b) Jendela luar diperbolehkan namun harus memiliki tirai yang bisa mengatur masuknya sinar matahari.
 6. Pengendalian Suara (Akustik) :
 - a) Tingkat kebisingan tidak boleh melebihi 45 dB. Suara keras (alarm alat, percakapan staf, pintu menutup) dapat menyebabkan stres pada bayi (high risk pendarahan otak).
 - b) Lantai dan plafon harus menggunakan material penyerap suara.
 7. Ventilasi Udara : Menggunakan sistem filtrasi minimal HEPA Filter dengan pertukaran udara minimal 6 - 12 kali per jam.
 8. Kelistrikan :
 - a) Setiap titik inkubator wajib memiliki minimal 6 - 12 stop kontak (untuk ventilator, monitor, pump, dll).
 - b) Wajib terhubung ke sistem UPS (listrik tanpa jeda) dan genset otomatis.
 9. Persyaratan Higienitas dan Sanitasi
 - a) Wastafel Cuci Tangan : Harus ada di setiap pintu masuk dan di dalam area perawatan dengan rasio 1 wastafel untuk setiap 3 tempat tidur. Kran harus menggunakan sensor atau siku (tidak boleh sentuh tangan).
 - b) Material Lantai: Harus seamless (tanpa sambungan), tidak licin, dan memiliki *hospital coving* (lengkungan di sudut antara lantai dan dinding agar tidak ada debu mengendap).
 10. Nurse Station perawat harus terletak di pusat blok yang dilayani agar perawat dapat mengawasi pasiennya secara efektif, maksimum melayani 4 tempat tidur
 11. Adanya CCTV yang aktif 24 jam guna untuk menjaga keselamatan bayi atau menghindari adanya menculikan bayi atau kejadian bayi tertukar.

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pelayanan yang dapat dilakukan di ruang NICU

Kemampuan pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) secara umum dikategorikan berdasarkan tingkat kompleksitas kasus dan ketersediaan sumber daya medis. Berikut adalah pembagian kemampuan pelayanan NICU berdasarkan tingkatannya:

1. Pelayanan Level I (*Basic Care*)

Fokus utama adalah perawatan bayi baru lahir yang sehat dan stabil. Kemampuannya meliputi :

- a. Resusitasi neonatus dan stabilisasi bayi sebelum ditransfer ke fasilitas yang lebih tinggi.
- b. Perawatan bayi dengan usia kehamilan 35–37 minggu yang stabil secara fisiologis.
- c. Stabilisasi bayi yang lahir kurang dari 35 minggu atau sakit sampai dapat dipindahkan.

2. Pelayanan Level II (*Specialty Care / High Care*)

Ditujukan untuk bayi prematur atau bayi sakit yang memerlukan perawatan intensif namun tidak memerlukan dukungan hidup tingkat lanjut dalam jangka panjang. Kemampuannya meliputi :

- a. Bayi Prematur Sedang : Usia kehamilan >32 minggu atau berat lahir >1500 gram.
- b. Stabilisasi & Resusitasi : Mampu melakukan resusitasi neonatus dan stabilisasi bayi sakit sebelum dirujuk ke RS yang lebih tinggi (Tipe B atau A).
- c. Dukungan Pernapasan Non-Invasif : Penggunaan CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) atau High Flow Nasal Cannula (HFNC)
- d. Nutrisi & Terapi : Pemberian nutrisi parenteral total (infus) dan fototerapi untuk bayi kuning (ikterus).

4.2 Pelayanan yang tidak dapat dilakukan di ruang NICU

Berikut adalah kemampuan pelayanan NICU yang tidak bisa (atau secara standar tidak disarankan) yaitu :

1. Perawatan Bayi Sangat Prematur (*Extreme Prematurity*)

- a. Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR): Bayi dengan berat <1000 gram (ELBW - *Extremely Low Birth Weight*).
- b. Usia Kehamilan Sangat Muda: Bayi yang lahir pada usia gestasi <28–30 minggu. Kondisi ini membutuhkan inkubator tingkat tinggi dengan kontrol kelembapan (humidity control) yang sangat presisi dan pemantauan ketat yang biasanya hanya tersedia di Level III/IV.

2. Dukungan Pernapasan Tingkat Lanjut (*Advanced Ventilation*)

- a. HFO (*High Frequency Oscillation*) : Ventilasi frekuensi tinggi untuk bayi dengan gagal napas berat atau kebocoran udara paru (pneumotoraks).
- b. *Inhaled Nitric Oxide* (iNO) : Terapi gas khusus untuk bayi dengan hipertensi paru berat (PPHN).
- c. ECMO (*Extracorporeal Membrane Oxygenation*): Alat pengganti fungsi jantung dan paru-paru (hanya tersedia di RS rujukan nasional/Tipe A).

3. Bedah Pediatrik Kompleks

Tindakan yang tidak bisa dilakukan antara lain :

- a. Operasi kelainan kongenital berat (misalnya : *Gastroschisis*, *Omphalocele*, atau *Atresia Esofagus*).
- b. Operasi jantung terbuka atau penutupan PDA (*Patent Ductus Arteriosus*) secara bedah.
- c. Tindakan bedah saraf pada bayi (misalnya pemasangan VP Shunt untuk hidrosefalus).

4. Skrining dan Terapi Sub-Spesialis Lanjutan

Beberapa pemeriksaan penunjang yang memerlukan keahlian khusus sering kali tidak tersedia :

- a. Skrining ROP (*Retinopathy of Prematurity*): Pemeriksaan mata pada bayi prematur oleh spesialis mata konsultan vitreoretina.
- b. Ekokardiografi Neonatus: Pemetaan jantung bayi secara mendalam oleh Konsultan Kardiologi Anak.
- c. *Dialisis Peritoneal*: Cuci darah pada bayi yang mengalami gagal ginjal akut.

5. Terapi Pendinginan Tubuh (*Therapeutic Hypothermia*)

Terapi ini dilakukan pada bayi yang mengalami asfiksia berat (kekurangan oksigen saat lahir) untuk mencegah kerusakan otak permanen. Prosedur ini memerlukan alat *cooling blanket* khusus dan pemantauan aktivitas listrik otak (aEEG) yang berkelanjutan, yang biasanya hanya ada di RS pendidikan atau Tipe A.

BAB V

TATA LAKSANA

5.1 Kriteria pasien masuk ruang NICU

Sebelum pasien masuk NICU, keluarga harus mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapat perawatan di NICU, serta tindakan medis yang mungkin dilakukan selama pasien dirawat di NICU. Penjelasan tersebut diberikan oleh perawat NICU atau dokter spesialis anak yang menangani pasien. Atas penjelasan tersebut keluarga dapat menerima/ menyatakan persetujuan untuk dirawat NICU. Persetujuan dinyatakan dengan menandatangani formulir informed consent.

- a. Syndrome Gawat Nafas/ *Respiratory Distress Syndrome*
- b. *Retinopathy of Prematurity* (ROF)
- c. *Transient Tachycardia of Newborn* (TTN)
- d. *Hyalin Membrane Disease* (HMD)
- e. Pneumonia neonatal
- f. Asfiksia
- g. Aspirasi meconium
- h. Ancaman gagal nafas dan gagal nafas
- i. *Bronchopulmonary dysplasia* (BPD), memerlukan oksigenasi intensif dan agresif
- j. Anemia
- k. Apnea
- l. Perdarahan Saluran Cerna atas dan bawah yang masif
- m. *Necrotizing Enterocolitis Necrotion* (NEC)
- n. Syok Hipovolemik
- o. Post Resusitasi
- p. Kejang
- q. Kern ikterik/ *encephalopathy hiperbilirubinemia*
- r. *Hemorrhagic Disease of newborn* (HDN)
- s. Bayi berat badan lahir amat/ sangat rendah (<1500 gram) atau bayi dengan usia gestasi <34 minggu yang belum mendapatkan obat pematangan paru
- t. Ikterik Neonatorum yang perlu terapi fototerapi dan terapi cairan dengan hasil bilirubin bayi > 16 mg/dl
- u. Neonatus yang memerlukan nutrisi parenteral total atau parsial

5.2 Kriteria pasien keluar NICU

- e. Bayi telah menunjukkan tanda vital stabil di boks terbuka selama 24 - 48 jam.
Normalnya, suhu tubuh bayi 36,50 C - 37,50 C, frekuensi pernapasan 30 - 40 x/mt, nadi 120 - 160 x/mnt.
- f. Keberhasilan menyusui sudah mulai tercapai
- g. Penambahan berat badan dengan pemberian asupan per oral telah terlihat
- h. Semua obat yang diperlukan dapat diberikan per oral
- i. Nilai laboratorium telah normal
- j. Ibu dan ayah memperlihatkan kemampuan untuk mengasuh neonatus
- k. Pasien meninggal
- l. Rujuk
- m. Pulang Paksa (APS)

5.3 Monitoring Dan Evaluasi

Pasien Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menggunakan lembar kardek guna mewujudkan pelayanan NICU yang aman dan mengutamakan keselamatan pasien.

Monitoring dan evaluasi dimaksud harus ditindaklanjuti untuk menentukan faktor-faktor yang potensial berpengaruh agar dapat diupayakan penyelesaian yang efektif.

5.4 Jenis Pelayanan di ruang NICU

- 5.4.1 Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis.
- 5.4.2 Perawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan secara berkala.
- 5.4.3 Edukasi keluarga pasien oleh perawat dan TIM kesehatan lain.
- 5.4.4 Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan.
- 5.4.5 Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
- 5.4.6 Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- 5.4.7 Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapeutik.
- 5.4.8 Pemberian obat-obatan pada pasien sesuai dengan catatan daftar obat pasien dan instruksi dokter spesialis.
- 5.4.9 Pelayanan Tranfusi Darah.

5.5 Penggunaan Alat Medik

- a. Inkubator
- b. Baby scale
- c. Neonatal transport incubator
- d. Infusion pump
- e. Suction
- f. Standar infuse
- g. Bag mask neonates
- h. Termometer digital
- i. Phototerapi
- j. Humidifier
- k. Pulse oximetri
- l. CPAP
- m. Stetoskop bayi
- n. Ventilator
- o. Syringe Pump

5.6 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

- a. Obserasi keadaan umum pasien tiap 1 jam
- b. Observasi tanda – tanda vital tiap 1 jam
- c. Pengukuran intake dan output pasien tiap 24 jam
- d. Merubah posisi 2 – 3 jam sekali.

5.7 Pasien Pulang

1. Resume Pasien Pulang
 - a. Pasien pulang diperoleh setelah hasil evaluasi dokter tindakan terapi diberhentikan dan perbolehkan pulang
 - b. Lakukan resume pasien sebagai bahan untuk kontrol dan keperluan riwayat penyakit dalam pertimbangan terapi yang akan datang
2. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut lakukan edukasi asuhan perawatan dirumah yang berhubungan dengan asuhan:

 - a. Perawatan tali pusat
 - b. Perawatan menjemur bayi
 - c. Edukasi laktasi
 - d. Pemberian obat
 - e. Hidup sehat
 - f. Asuhan yang bersifat khusus bagi pasien dengan kasus khusus
3. Pasien Meninggal
 - a. Bila pasien meninggal lakukan asuhan jenazah di ruangan perinatologi
 - 1) Buka semua peralatan yang menempel di pasien
 - 2) Buka baju pasien
 - 3) Ikat tangan pasien tangan kanan memegang tangan kiri
 - 4) Tutup dengan laken
 - 5) Tunggu 2 jam
 - 6) Informasikan kebagian ambulan dan jenazah
 - b. Pasien dirujuk

Pasien dirujuk bila atas indikasi tidak dapat dilakukan di rumah sakit dikarenakan sarana tidak lengkap, permintaan sendiri dari pasien adapun persiapan yang harus dilakukan

 - 1) Lakukan komunikasi dengan tempat yang akan menerima rujukan (lihat Panduan Transfer Pasien)
 - 2) Bila sudah tersedia ruangan maka hubungi ambulan
 - 3) Setelah siap ambulan kondisikan tim yang akan merujuk sesuai dengan kondisi pasien (lihat pada panduan transfer pasien)
 - 4) Transportasi pasien menggunakan inkubator transport

5.8 Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan

1. Laporan Harian

Laporan harian dibuat untuk seluruh pasien NICU, laporan ini terdiri dari laporan 3 shift yaitu pagi, siang dan malam yang dilakukan saling berkesinambungan isi dari laporan tersebut adalah:

- a) Identitas pasien
- b) Observasi tanda – tanda vital
- c) Cairan yang didapat pasien, dan jumlah cairan yang keluar dan masuk.
- d) Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien setiap harinya

e) Obat-obatan yang didapat pasien dan alat – alat yang terpasang pada pasien

2. Laporan bulanan

Laporan kepala ruang kepada Kabid Keperawatan

BAB VI

LOGISTIK

Kebutuhan barang-barang logistik di Instalasi NICU terdiri dari barang tetap dan barang habis pakai. Barang tetap terdiri dari peralatan medis, peralatan keperawatan, alat tenun dan peralatan rumah tangga. Sedangkan barang habis pakai terdiri dari : Obat-obatan dan bahan habis pakai alkes (BHP) dan Alat Tulis Kantor (ATK).

Untuk proses pengadaan barang habis pakai di tiap ruangan melalui 3 proses, yaitu :

1. Perencanaan
Kepala Ruangan mendata kebutuhan barang (BHP dan ATK) dalam 1 minggu
2. Permintaan
Permintaan kebutuhan barang perminggu ruangan dilakukan setiap hari senin sesuai jadwal ke bagian umum, dan permintaan BHP farmasi dilakukan pada hari sabtu
3. Penyimpanan
Penyimpanan barang dilakukan di tiap ruangan selama 1 minggu

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode alat	Ket.
1	Medis – Listrik	Nebulizer	1	baik	RSPHM/F02402/043/102/22	
2		Suction bayi	1	Baik	15YE3.196	
3		Laringoskop neo	1	Baik	-	
4		Infant warmer	2	Baik	1. 21A1AB02005 2. 150801128	
5		Inkubator	5	Baik	1. 01BAK607019 2. 01AHZB02006 3. 01B22D01029 4. 0111AB07444 5. 01170903023	
6		Inkubator transport	1	Baik	021TC-22-0002	
7		Cuvis	4	Baik	-	
8		Lampu fototerapi	2	Baik	1. PT-001 2. EAG60101	
9		Cek GDA	1	Baik	-	
10		Pulse Oxymeter Bionet/ Oxywave neo	3	Baik	1. EHAA0M 2. 02T1000066 3. 0211200020	
11		Neo-puff infant T-piece R	1	baik	180806016627	
12		Thermo gun	1	baik	RSPHM.F03068.040.088.2020.1	

13		CPAP	5	Baik	1. 30111301077 2. 50111501105 3. 50111501110	
14		Ventilator	1	Baik	EE-23006435	
15		Box bayi	15	Baik		

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan	
1	Medis – Non Listrik	Gunting tali pusat	9	baik	-	-
2		Ambu Bag Bayi	3	baik	-	-
3		Stetoskop bayi	3	baik	-	-
4		Bengkok	1	baik	-	-
5		Oksigen transport	1	baik	-	-
6		Regulator Oksigen	5	baik	-	-
7		Box bayi	15	baik	-	-
8		Torniquet	1	baik	-	-

BHP

1		Alcohol swab	-	-	-	-
2		Hypafix	1box	baik	-	-
3		Plesterin	-	-	-	-
4		Elastomul	1 pcs	baik	-	-

Farmasi

1		Aminophylline 10 ml	1	-	24 mg/ml	Ed 08-28
2		Atropine sulfat 1ml (0,25mg/1ml)	2	-	0,25mg/ml	Ed 03-28
3		Dexametason 1ml (5mg/ml)	1	-	5 mg/ml	Ed 10-27
4		Diazepam rectal	1	-	5mg	Ed 07-27
5		Dobutamine (50mg/ml)	1	-	50mg/ml	Ed 07-29
6		Ephineprine 1ml (1mg/ml)	4	-	1mg/ml	Ed 09-28
7		Dopamine	1		200mg/5ml	Ed 07-27
8		Infus D10%	1		500ml	Ed 11-27

9		Infus Gelafusal 500ml	1	-	500ml	Ed 01-27
10		Lidocaine 2% 2ml	3	-	100mg/2ml	Ed 02-29
11		Natrium Phenytoin 2ml	1	-	50mg/ml	Ed 07-27
12		Phenobarbital 1ml	1	-	50mg/ml	Ed 07-26
13		ETT uncuffed no.2.0	1	-	-	Ed 08-29
14		ETT uncuffed no. 2,5	1	-	-	Ed 05-29
15		ETT uncuffed no. 3	1	-	-	Ed 05-29
16		Hi oxygen masker anak	1	-	-	Ed 01-29
17		Handscoen steril no. 6,5	1	-	-	Ed 10-30
18		Iv cath no.24	1	-	-	Ed 06-29
19		Iv cath no. 26	1	-	-	Ed 01-30
20		Perfusor white	1	-	150 cm	Ed 09-30
21		Sprit 10cc terumo	2	-	-	Ed 06-30
22		Sprit 5cc terumo	2	-	-	Ed 10-29
23		Sprit 3cc terumo	2	-	-	Ed 09-30
24		Sprit 1cc terumo	2	-	-	Ed 01-30
25		Spalk 5x10 cm	1	-	-	-
26		Suction Catheter no. 6	1	-	-	Ed 12-28
27		Suction Catheter no 8	1	-	-	Ed 02-28
28		Three way catheter stopcock	1	-	-	Ed 09-30
29		Terufusion terumo	1	-	-	Ed 06-27

No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode alat	Ket.
1	Non Medis – Listrik	Monitor Komputer	2	baik	RSPH.2.D.MATER.2017	-
2		Mouse	2	baik	-	-

3		CPU	2	baik	-	-
4		Key board	2	baik	-	-
5		AC	3	baik	-	
6		Remote AC	2	baik	-	-
7		Dispenser	1	baik	DP	
8		Jam Dinding	1	baik	-	-
9		Kulkas	1	baik	RSPH.3.M.PERI.2017	-
10		Kabel Olor	1	baik	-	-
11		HP Unit	1	baik	-	-
12		Seteril Botol Bayi	1	baik	RSPH.1.B2.PERI.2017	-
13		Smart lock door	2	baik	-	
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Keterangan	
1	Non Medis – Non Listrik	Meja Nurse Station	1	baik	-	-
2		Gunting kertas Besar	1	baik	-	-
3		Penggaris	1	baik	-	-
4		Troli Injeksi	2	baik	-	-
5		Box CSSD	1	baik	-	-
6		Box emergency	1	baik	-	-
7		Rak form	1	baik	-	-
8		Lemari	2	baik	-	-
9		Sampah medis	2	baik	-	-
10		Sampah Non Medis	2	baik	-	-
11		Standard Infus (roda)	5	baik	-	-
12		Kursi perawat	4	baik	-	-
13		Stapler Besar	1	baik	-	-
14		Stapler Kecil	1	baik	-	-
15		Bak stempel	2	baik	-	-
16		Stempel konfirmasi	1	baik	-	-
17		Stempel prima husada	1	baik	-	-
18		Pemotong isolasi	2	baik	-	-
19		Baby Tofel	2	baik	-	-
20		Sprei bayi/ linen bayi	40	baik	-	-
21		Sarung bantal	40	baik	-	-
22		Sarung guling	40	baik	-	-

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 PENGERTIAN

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman, guna mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem tersebut meliputi : assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka upaya pelaksanaan keselamatan pasien di RS perlu dilakukan. Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan RS terutama di dalam melaksanakan keselamatan pasien sangat diperlukan suatu pedoman yang jelas sehingga angka kejadian KTD dapat dicegah sedini mungkin.

7.2 TUJUAN

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.
4. Terlaksananya program – program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

7.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

1. Ketepatan Identifikasi Pasien
 - a. Gelang Identitas: Setiap bayi wajib menggunakan minimal dua identitas (Nama lengkap ibu dan Tanggal Lahir)
 - b. Warna Gelang: Biru untuk laki-laki, Merah muda untuk perempuan.
 - c. Verifikasi Double Check: Perawat harus memeriksa identitas bayi sebelum memberikan obat, mengambil sampel darah, atau memberikan ASI perah (ASIP).
 - d. Papan Identitas: Di setiap inkubator harus terpasang identitas bayi yang jelas.
2. Peningkatan Komunikasi Efektif
 - a. Teknik SBAR & TBAK: Menggunakan metode *Situation, Background, Assessment, Recommendation* (SBAR) saat operan shift atau melapor ke dokter melalui telepon. Penerima instruksi wajib Menulis, Membaca kembali, dan Mengonfirmasi (TBAK).
 - b. Pelaporan Nilai Kritis: Hasil laboratorium yang kritis (misal : Gula darah sangat rendah atau Hb rendah) harus dilaporkan ke dokter penanggung jawab dalam waktu <15 menit.
 - c. Serah Terima (*Handover*): Menggunakan formulir serah terima terstandar antara perawat ruang bersalin/OK ke perawat NICU.

-
3. Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (*High-Alert*)
 - a. Double Check: Pemberian obat *high-alert* (seperti elektrolit pekat, insulin, atau heparin) wajib diperiksa oleh dua orang perawat yang berbeda (perhitungan dosis dan jenis obat).
 - b. Labeling: Obat yang sudah dilarutkan dalam *syringe pump* harus diberi label: Nama obat, dosis, jam mulai, dan nama perawat.
 - c. Penyimpanan: Obat elektrolit pekat tidak boleh disimpan di area perawatan bayi, melainkan di lemari terkunci khusus.
 - d. LASA (*Look Alike Sound Alike*): Obat dengan nama atau kemasan mirip harus diletakkan berjauhan dan diberi stiker "LASA".
 4. Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien Operasi
 - a. Penandaan Lokasi (*Marking*): Dilakukan jika bayi memerlukan tindakan bedah atau prosedur invasif (misal: pemasangan *chest tube*).
 - b. Surgical Safety Checklist: Dilakukan prosedur *Sign In*, *Time Out*, dan *Sign Out* untuk setiap tindakan invasif di NICU.
 5. Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
 - a. Kepatuhan Cuci Tangan (5 Moments): Wajib melakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun atau *handrub* sesuai standar WHO.
 - b. Akses Terbatas: Pengunjung wajib melepas perhiasan (jam tangan, cincin) dan menggunakan baju khusus/apron sebelum masuk NICU.
 - c. Sterilitas Alat: Pembersihan rutin inkubator, penggantian sirkuit ventilator, dan penggunaan alat habis pakai (*disposable*) untuk setiap bayi.
 - d. Bundles Infeksi: Penerapan protokol pencegahan infeksi aliran darah (VAP, ISK, dan IDO).
 6. Pengurangan Risiko Pasien Jatuh
 - a. Keamanan Inkubator: Pastikan pintu inkubator atau pagar pembatas infant warmer selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci saat bayi tidak sedang dalam tindakan.
 - b. Fiksasi Alat: Pastikan kabel monitor, selang ventilator, dan infus terfiksasi dengan baik agar tidak menarik bayi.
 - c. Edukasi Orang Tua: Mengajarkan orang tua cara memegang bayi yang benar saat melakukan *Kangaroo Mother Care* (PMK) agar bayi tidak merosot atau jatuh.
 7. Keselamatan Penggunaan Oksigen: Pemantauan saturasi oksigen (SpO₂) secara ketat untuk mencegah retinopati (kerusakan mata) akibat kelebihan oksigen (*Retinopathy of Prematurity*).
 8. Keamanan Pemberian ASIP: Verifikasi label ASIP (Nama bayi, tanggal peras) bersama saksi untuk mencegah tertukarnya ASI antar bayi.
 9. Manajemen Alarm: Setiap alarm pada monitor atau ventilator harus segera direspon (tidak boleh di-*silent* terus menerus).

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka /cedera, cacat /kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan mesin dan lingkungan secara luas.

Dalam menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Instalasi NICU disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit, dengan selalu berkoordinasi dengan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS Prima Husada dan unit terkait lainnya.

8.2 Prinsip Dasar Usaha Kesehatan Kerja

Prinsip dasar Usaha Kesehatan Kerja (UKK) di rumah sakit bertujuan untuk menciptakan keserasian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Tujuannya agar setiap pekerja rumah sakit dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

1. Kapasitas Kerja (Status Kesehatan Pekerja)

Prinsip ini berfokus pada kesiapan fisik dan mental petugas sebelum dan selama bekerja.

- a. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Melakukan *medical check-up* rutin bagi staf NICU (misalnya pemeriksaan paru atau status imunisasi).
- b. Pemberian Imunisasi: Mengingat risiko tinggi di ruang bayi, petugas wajib mendapatkan vaksinasi Hepatitis B dan Influenza.
- c. Kebutuhan Gizi: Memastikan petugas mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga imunitas.

2. Beban Kerja (Manajemen Tugas)

Prinsip ini mengatur agar tugas yang diberikan tidak melampaui kemampuan fisik dan mental petugas.

- a. Shift Kerja yang Manusiawi: Pengaturan jadwal jaga agar petugas NICU tidak mengalami kelelahan kronis (*burnout*) yang bisa memicu human error.
- b. Rasio Petugas dan Pasien: Di NICU, beban kerja sangat tinggi. Rasio yang tidak seimbang (misal 1 perawat memegang 4 bayi kritis) melanggar prinsip beban kerja dan membahayakan keselamatan kerja.
- c. Ergonomi: Pengaturan posisi tubuh saat mengangkat bayi, membungkuk di depan inkubator, atau mendorong alat agar petugas tidak mengalami cedera tulang belakang (*Low Back Pain*).

3. Lingkungan Kerja (Fisik, Kimia, Biologi)

Prinsip ini memastikan tempat kerja bebas dari bahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

- a. Bahaya Biologi: Pengendalian infeksi melalui APD, pengelolaan jarum suntik yang benar untuk mencegah tertusuk (NSI), dan sterilisasi ruangan.
- b. Bahaya Fisik: Pengendalian kebisingan alarm alat, paparan radiasi dari X-ray portable, dan pencahayaan yang cukup.

- c. Bahaya Kimia: Pengelolaan bahan sterilisasi (seperti alkohol atau desinfektan tingkat tinggi) agar tidak terhirup atau merusak kulit petugas.
- d. Bahaya Psikososial: Penanganan stres kerja akibat sering menghadapi kematian bayi atau keluhan keluarga pasien.

8.3 Tujuan Keselamatan Kerja

1. Perlindungan Sumber Daya Manusia (SDM)
Tujuan utama K3RS adalah melindungi dokter, perawat, bidan, penunjang medis, hingga tenaga administrasi dari:
 - a. Kecelakaan Kerja: Mencegah insiden fisik seperti tertusuk jarum (needle stick injury), terpeleset, atau cedera punggung akibat mengangkat beban/pasien.
 - b. Penyakit Akibat Kerja (PAK): Mencegah penularan infeksi (Hepatitis, HIV, TBC) serta dampak paparan bahan kimia dan radiasi dalam jangka panjang.
2. Peningkatan Mutu Pelayanan
Lingkungan kerja yang aman berpengaruh langsung pada kualitas layanan:
 - a. Jika petugas merasa aman dan sehat, konsentrasi dalam memberikan tindakan medis (terutama di unit kritis seperti NICU) akan meningkat.
 - b. Meminimalkan human error yang disebabkan oleh kelelahan atau kondisi lingkungan kerja yang buruk.
3. Menjamin Keselamatan Pasien dan Pengunjung
Meskipun fokus utama K3 adalah pekerja, tujuannya juga mencakup aspek publik:
 - a. Memastikan sarana dan prasarana (seperti lift, tangga, dan instalasi listrik) tidak membahayakan pasien dan pengunjung.
 - b. Mencegah terjadinya kebakaran atau kebocoran gas medis yang dapat mengancam nyawa seluruh penghuni rumah sakit.
4. Efisiensi dan Keberlangsungan Operasional
 - a. Mencegah Kerugian Material: Menghindari kerusakan alat kesehatan mahal akibat kelalaian operasional atau gangguan listrik.
 - b. Menghindari Pembiayaan Tambahan: Mengurangi biaya kompensasi kecelakaan kerja atau biaya pengobatan staf yang sakit akibat kerja.
 - c. Kepatuhan Hukum: Memastikan rumah sakit memenuhi standar akreditasi (STARKES) dan regulasi pemerintah sehingga izin operasional tetap terjaga.

8.4 Kapasitas Kerja dan Beban Kerja

1. Kapasitas Kerja
Kapasitas Kerja adalah kemampuan fisik dan mental seorang pekerja untuk melakukan pekerjaannya pada waktu tertentu. Kapasitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal petugas.
Komponen Kapasitas Kerja meliputi:
 - a. Status Kesehatan : Bebas dari penyakit menular atau kronis yang dapat mengganggu kinerja (misal: perawat NICU tidak boleh sedang menderita flu berat karena berisiko menularkan ke bayi).
 - b. Status Gizi : Kecukupan energi untuk menjalani shift kerja yang panjang.
 - c. Tingkat Pendidikan & Keterampilan : Keahlian spesifik yang dimiliki (misal: perawat NICU harus memiliki sertifikat pelatihan Resusitasi Neonatus).
 - d. Kondisi Psikologis : Kesiapan mental dalam menghadapi situasi gawat darurat (kode biru) atau menghadapi kematian pasien bayi.

- e. Kebugaran Fisik : Ketahanan tubuh terhadap kelelahan.
- 2. Beban Kerja
Beban Kerja adalah sekumpulan tugas atau target yang diberikan kepada pekerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja di rumah sakit bersifat sangat dinamis.
Jenis Beban Kerja di Rumah Sakit:
 - a. Beban Kerja Fisik : Aktivitas yang mengandalkan tenaga otot, seperti mengangkat bayi, mendorong inkubator transport, membungkuk di depan infant warmer, atau melakukan pijat jantung saat resusitasi.
 - b. Beban Kerja Mental: Aktivitas yang mengandalkan pikiran dan emosi, seperti menghitung dosis obat mikro (misal: dopamin dengan dosis \$mcg/kgBB/menit\$), memantau layar monitor selama berjam-jam, serta memberikan edukasi kepada orang tua yang sedang berduka atau cemas.

8.5 Lingkungan Kerja dan Penyakit Kerja yang Ditimbulkan

- 1. Faktor Biologi (Risiko Tertinggi di RS)
Lingkungan yang mengandung mikroorganisme patogen (virus, bakteri, jamur).
 - a. Penyebab : Paparan darah, cairan tubuh (urin, feses bayi), atau droplet saat melakukan tindakan medis (intubasi, suction).
 - b. Penyakit yang Ditimbulkan :
 - 1) Hepatitis B dan C serta HIV : Akibat tertusuk jarum (Needle Stick Injury).
 - 2) Tuberkulosis (TBC) : Akibat paparan udara dari pasien atau rekan kerja.
 - 3) Infeksi Saluran Pernapasan : Akibat paparan virus di area perawatan.
- 2. Faktor Fisik
Unsur-unsur fisik di lingkungan kerja yang melampaui ambang batas.
 - a. Penyebab : Kebisingan alarm monitor/ventilator, suhu ruangan yang dingin, radiasi X-ray, dan pencahayaan.
 - b. Penyakit yang Ditimbulkan :
 - 1) Gangguan Pendengaran : Akibat paparan bising alarm terus-menerus di NICU.
 - 2) Katarak atau Kerusakan Jaringan: Akibat paparan radiasi (X-ray portable) tanpa pelindung timbal (apron).
 - 3) Hipotermia Ringan : Akibat bekerja di ruangan ber-AC suhu rendah 24 – 26 c dalam waktu lama.
- 3. Faktor Ergonomi (Fisik-Mekanis)
Ketidaksesuaian antara desain alat kerja dengan anatomi tubuh petugas.
 - a. Penyebab : Membungkuk terlalu lama di depan inkubator, mengangkat bayi/peralatan dengan posisi salah, atau berdiri terlalu lama saat observasi.
 - b. Penyakit yang Ditimbulkan :
 - 1) Low Back Pain (LBP) : Nyeri punggung bawah kronis.
 - 2) Musculoskeletal Disorders (MSDs) : Gangguan otot, saraf, dan tendon (misal: Carpal Tunnel Syndrome).
 - 3) Varises : Akibat berdiri terlalu lama tanpa istirahat.
- 4. Faktor Kimia
Paparan zat kimia berbahaya yang digunakan untuk operasional RS.
 - a. Penyebab : Desinfektan tingkat tinggi (*Glutaraldehyde*), alkohol, gas anestesi, atau merkuri (jika alat pecah).

- b. Penyakit yang Ditimbulkan :
 - 1) Dermatitis Kontak : Iritasi kulit akibat sering mencuci tangan dengan antiseptik atau terpapar cairan kimia.
 - 2) Asma Kerja/Iritasi Saluran Napas : Akibat menghirup uap desinfektan atau gas medis.
- 5. Faktor Psikososial
Kondisi lingkungan kerja yang memengaruhi kesehatan mental.
 - a. Penyebab : Stres tinggi merawat bayi kritis, beban kerja berlebih, konflik antarstaf, atau sering menghadapi kematian bayi.
 - b. Penyakit yang Ditimbulkan :
 - 1) Burnout Syndrome : Kelelahan mental dan fisik yang luar biasa.
 - 2) Gangguan Tidur (Insomnia) : Akibat pola kerja shift yang tidak teratur.
 - 3) Psikosomatik : Keluhan fisik (lambung, sakit kepala) yang dipicu oleh stres kerja.

8.6 Klasifikasi Kecelakaan Kerja

1. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kejadian (Kecelakaan Fisik)
Ini adalah kecelakaan yang paling sering dilaporkan oleh staf di unit medis maupun non-medis :
 - a. Kecelakaan Akibat Benda Tajam (Sharps Injury) : Tertusuk jarum suntik (Needle Stick Injury), tergores pisau bedah (skalpel), atau pecahan ampul obat. Ini adalah risiko tertinggi penularan infeksi darah (Hepatitis, HIV).
 - b. Terpeleset, Tersandung, dan Terjatuh (Slips, Trips, and Falls) : Akibat lantai yang basah setelah dipel, kabel alat medis yang menjuntai di lantai (terutama di NICU), atau tangga yang licin.
 - c. Cedera Punggung dan Otot (Musculoskeletal Injury) : Cedera akibat salah posisi saat mengangkat pasien, memindahkan tempat tidur, atau membungkuk terlalu lama saat tindakan.
 - d. Terpapar Bahan Berbahaya : Terkena percikan cairan kimia desinfektan, cairan tubuh pasien ke mata/mulut, atau kebocoran gas medis.
2. Klasifikasi Berdasarkan Penyebab (Hazard)
Kecelakaan dikelompokkan menurut sumber bahayanya:
 - a. Bahaya Biologi : Terpapar virus, bakteri, atau jamur melalui kontak langsung atau udara.
 - b. Bahaya Fisik : Terkena ledakan tabung gas, tersengat listrik dari alat medis yang bocor, atau paparan radiasi berlebih.
 - c. Bahaya Kimia : Keracunan atau iritasi akibat bahan pembersih ruangan atau gas anestesi.
 - d. Bahaya Psikososial : Kekerasan fisik atau verbal dari pasien/keluarga pasien terhadap petugas.
3. Klasifikasi Berdasarkan Dampak / Keparahan
Digunakan untuk menentukan tingkat urgensi pelaporan ke manajemen RS atau BPJS Ketenagakerjaan:

-
- a. Kecelakaan Ringan : Kecelakaan yang tidak mengakibatkan kehilangan hari kerja (petugas bisa langsung bekerja kembali setelah diobati/P3K). Contoh: Tergores ampul kecil.
 - b. Kecelakaan Sedang : Kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja tetapi tidak menyebabkan cacat tetap. Petugas butuh istirahat beberapa hari. Contoh: Terpeleset hingga memar/terkilir.
 - c. Kecelakaan Berat : Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap (fisik atau fungsi organ) atau kehilangan anggota tubuh.
 - d. Kecelakaan Fatal (Death) : Kecelakaan yang mengakibatkan kematian pekerja.
4. Klasifikasi Berdasarkan Unsur "Nyaris" (*Teori Iceberg*)
- Sama seperti keselamatan pasien, kecelakaan kerja juga memiliki tingkatan sebelum terjadi cedera :
- a. Kejadian Nyaris Celaka (KNC) / Near Miss : Suatu kejadian yang hampir menimbulkan kecelakaan tetapi tidak terjadi (misal: hampir terpeleset karena lantai licin tapi bisa berpegangan).
 - b. Kejadian Kecelakaan : Sudah terjadi kontak dan menimbulkan cedera.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU

9.1 Upaya Peningkatan Mutu

Upaya untuk menjamin mutu pelayanan asuhan, rumah sakit membuat Program Pengendalian dan Peningkatan Mutu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu tersebut.

Perumusan dan penyusunan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui masukan dari seluruh jajaran dan staf yang terlibat dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Direksi.

9.2 Definisi Indikator

1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi
 - 1) Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan
 - 2) Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.
 - 3) Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan)
 - 4) Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti :
 - a) Pemberian pengobatan : pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi
 - b) Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit
 - c) Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain
 - d) Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar
 - 5) Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Waktu *visite* dokter adalah waktu kunjungan dokter untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 - 1) *Clinical Pathway* adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit.
 - 2) Kepatuhan terhadap *clinical pathway* adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan *clinical pathway* yang ditetapkan Rumah Sakit.
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
 - 1) Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi:
 - a) *Assesment* awal risiko jatuh
 - b) *Assesment* ulang risiko jatuh

- c) Intervensi pencegahan risiko jatuh
 - 2) Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
2. Indikator Mutu Prioritas Unit
- a. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama. Dalam konteks rumah sakit, dihitung berdasarkan kematian bayi yang lahir hidup di fasilitas tersebut.
 - b. Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pada pasien dengan indikasi
Keterlambatan pemasangan intubasi adalah tindakan intubasi yang dilakukan melebihi batas waktu standar sejak indikasi ditegakkan atau sejak pasien dinyatakan membutuhkan airway definitif (misalnya >10–15 menit di IGD/ruang rawat tanpa alasan klinis yang dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi).
 - c. Kejadian SHK yang di tolak dinkes
Kejadian SHK yang ditolak Dinkes adalah jumlah sampel skrining hipotiroid kongenital yang tidak diterima/ditolak oleh Dinas Kesehatan karena tidak memenuhi kriteria (misalnya: sampel tidak sesuai standar, pengisian identitas tidak lengkap, atau keterlambatan pengiriman).
3. Indikator Mutu Unit
- a. Kejadian kesalahan asuhan medis Dpjp
Kesalahan asuhan medis Dpjp adalah Jumlah kejadian kesalahan asuhan medis yang dilakukan oleh DPJP berdasarkan hasil audit klinis, laporan insiden keselamatan pasien, atau telaah kasus
 - b. Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien
Ketidakpatuhan visite DPJP adalah kejadian dimana DPJP tidak melaksanakan visite sesuai ketentuan (frekuensi dan waktu yang ditetapkan rumah sakit) dan/atau tidak mendokumentasikan hasil visite di rekam medis pada periode tertentu.
 - c. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap
Ketidaklengkapan E-RM adalah persentase rekam medis elektronik pasien rawat inap yang tidak terisi lengkap sesuai elemen wajib dokumentasi asuhan (pengkajian, diagnosa, rencana terapi, implementasi, evaluasi, instruksi medis, verifikasi DPJP, dan tanda tangan elektronik) pada periode tertentu.

9.3 Kriteria

- 1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Tidak ada
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter
 - 1) Kriteria Inklusi : *Visite* dokter pada pasien rawat inap
 - 2) Kriteria Eksklusi :
 - a) Pasien yang baru masuk rawat inap hari itu
 - b) Pasien konsul
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
 - 1) Kriteria Inklusi : Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup *clinical pathway* yang diukur

-
- 2) Kriteria Eksklusi :
 - a) Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan.
 - b) Pasien yang meninggal
 - c) Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
 - 1) Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh
 - 2) Kriteria Eksklusi : Pasien yang tidak dapat dilakukan asesmen ulang maupun edukasi seperti pasien meninggal, pasien gangguan jiwa yang sudah melewati fase akut, dan pasien menolak intervensi
2. Indikator Mutu Prioritas Unit
- a. Angka Kematian bayi
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua bayi lahir hidup dan tercatat pada periode pengukuran.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Bayi lahir mati (stillbirth) tidak dihitung sebagai kelahiran hidup
 - b. Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pada pasien dengan indikasi
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua pasien dengan indikasi klinis intubasi (gagal napas, GCS $\leq$ 8, henti napas, distress berat, dll.)
 - 2) Kriteria Eksklusi : Pasien dengan DNR (Do Not Resuscitate), penolakan keluarga, atau kondisi khusus dengan pertimbangan klinis terdokumentasi.
 - c. Kejadian SHK yang di tolak dinkes
 - 1) Kriteria Inklusi : Semua sampel SHK yang dikirim ke Dinkes.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Sampel yang belum dikirim, sampel rusak sebelum pengiriman, atau data tidak terdokumentasi.
3. Indikator Mutu Unit
- a. Kejadian kesalahan asuhan medis Dpjp
 - 1) Kriteria Inklusi : Seluruh kejadian asuhan medis oleh DPJP yang terverifikasi melalui audit klinis, rekam medis atau laporan IKP.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Komplikasi bukan akibat kesalahan medis oleh DPJP, kejadian tidak terbukti dan data tidak lengkap
 - b. Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien
 - 1) Kriteria Inklusi : Seluruh pasien rawat inap yang berada dalam tanggung jawab DPJP pada periode audit.
 - 2) Kriteria Eksklusi : Pasien dengan kondisi tertentu yang memiliki justifikasi tertulis (misalnya pasien sudah rencana pulang sebelum jadwal visite atau kondisi force majeure terdokumentasi)
 - c. Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap
 - 1) Kriteria Inklusi : Seluruh rekam medis elektronik pasien rawat inap yang telah selesai dirawat (pasien pulang) pada periode audit
 - 2) Kriteria Eksklusi : Rekam medis dengan gangguan sistem (error IT terdokumentasi) atau kasus khusus dengan justifikasi tertulis.

9.4 Standar

1. Indikator Mutu Nasional
 - a. Kepatuhan Identifikasi : 100%
 - b. Kepatuhan Waktu Visite Dokter : $\geq 80\%$
 - c. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) : $\geq 80\%$
 - d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh : 100%
2. Indikator Mutu Prioritas Unit
 - a. Angka Kematian bayi : 0
 - b. Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pada pasien dengan indikasi : 0
 - c. Kejadian SHK yang di tolak dinkes : 0
3. Indikator Mutu Unit
 - a. Kejadian kesalahan asuhan medis Dpjp : 0%
 - b. Ketidakpatuhan DPJP dalam pelaksanaan visite pasien : 0%
 - c. Kelengkapan e-RM asuhan pasien selama di rawat inap : 0%

BAB X PENUTUP

Pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit* yang dilaksanakan di rumah sakit hendaknya senantiasa sejalan dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran. Selain itu, dalam rangka menyongsong era globalisasi dan menghadapi persaingan bebas, maka pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit* rumah sakit juga harus dipersiapkan secara profesional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit selanjutnya akan meningkatkan nilai jualnya.

Pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit* merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit, dan merupakan salah satu pelayanan yang dapat diunggulkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan.

Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan sistematis dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit* di rumah sakit yang tepat bagi pasien. Selain itu, pedoman ini bermanfaat bagi pengelola rumah sakit dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi kemajuan dan perkembangan pelayanan *Neonatus Intensive Care Unit*.

Malang, 08 September 2025

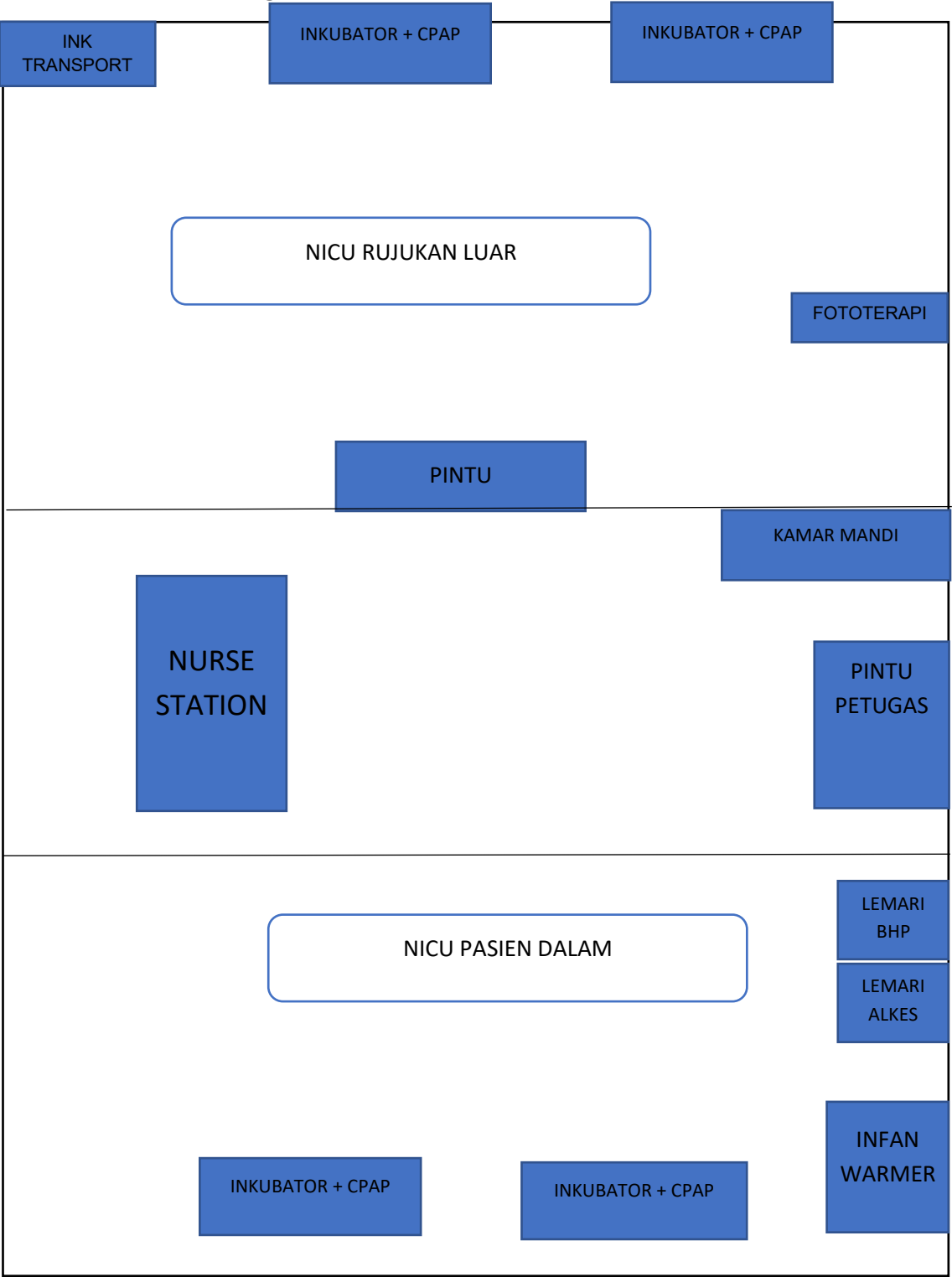
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN II :
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA NOMOR :
826.15/I-PDM/NICU/IX/2025
TENTANG : PEDOMAN
PELAYANAN NICU RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA

Lampiran Denah Ruangan NICU



LAMPIRAN III :

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA NOMOR : 826.15/I-
PDM/NICU/IX/2025 TENTANG :
PEDOMAN PELAYANAN NICU
RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA**

Alur pasien dari dan ke NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*)

